## << 2019 본3 학년말고사 내과 >>

**60Q 중 58Q 복원 완료**

전체적으로 탈야마. 믿었던 신장마저 Super 탈야마. 당해 내신 야마 탄 과목은 소화기에서 2문제 정도?

탈야마가 너무 많아서 **복원 및 정답 100% 믿지 말고 주변 내용 공부하시기 바랍니다**. (류마가 GE에 겹치는 듯한 문제들이 있었습니다, GE에 넣어둘게요. 심장내과는 EKG 때문에 다단없이 마지막에 배치)

### << 소화기내과 >>

**총 11문제 복원.**

1. 5년 전에 대장 내시경 했을 때는 정상이었는데 2년 만에 병원에서 4cm polypectomy 후 adenocarcinoma 생겼다. 이것의 원인은 무엇인가?

   A. Adenomatous polyp

   B. Tubulovillous polyp

   C. Juvenile polyp

   D. Peutz-Jegher polyp

   **E. Sessile serrated adenoma/polyp**

2. (연말 Y) 식후 심해진 상복부 통증을 호소하며 온 환자. Abdominal ultrasonography이다. (찍어보니 담석이 있었다.) 이 환자에게 먼저 처치해야 할 것은? (강의록사진)



   **A. 담낭 절제술**

   B. PTGBD

   C. UDCA

   D. 경과관찰

   E. 내시경적 유두 괄약근 절제술

3. Gastric ulcer가 있는 환자에게H.pylori 제균치료 반드시 해야 하는 경우는? (보기 불확실, 답 불확실) (최근에 guideline이 바뀌었다 합니다. 답 찾아보세요)

   A. 위축성위염

   B. GIST

   **C. 십이지장궤양**

   D. GERD

   E. ??

4. HBsAg(-) HBsAb(+) IgM HAV(+) anti HCV Ab(+) HCV RNA PCR(-), 진단?

   **A. 급성 A형 간염**

   B. 만성 C형 간염

   C. 급성 B형간염

   D. 만성 B 형 간염 + 급성 A형 간염

5. 이자에 낭종 보이는 영상. CEA가 700정도로 증가. 무슨 병변? (보기 다 한글. 최대한 비슷한 사진 찾으려 했으나 실패. Pseudocyst는 아니었고, Calcification이 정도껏 있었습니다.)

   A. 장액성낭종

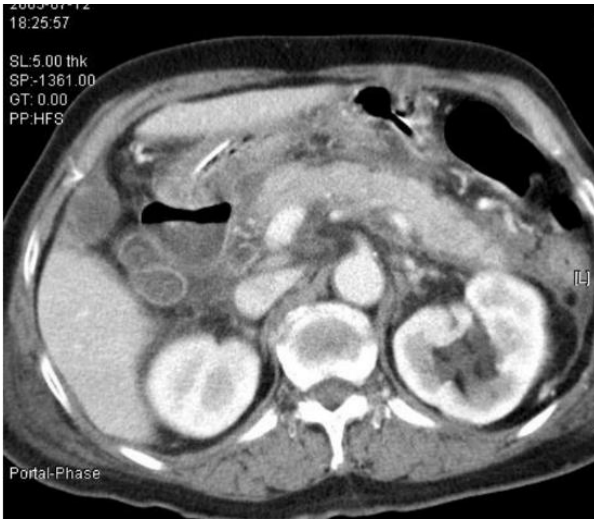
   B. 가성낭종

C. 선암

**D. IPMN**

E. 내분비종양

6. 한 달에 술은 한 두 번 마시는 52세 여성. 갑자기 발생한 배꼽 주위 통증을 호소하며 내원. CT는 다음과 같았음. 다음 해야 할 처치는? (비슷한 매뉴얼사진)




**A. 금식 후 수액치료**

B. 복부 초음파

C. EKG

D. 흉부 X-ray

7. 3년전 뇌경색 이후 2차 발병을 예방하기 위해서 NSAIDS를 꾸준히 먹는 72세 노인이 갑작스럽게 발생한 상복부 통증(배꼽 근처)으로 내원하였다. 다음 중 우선적으로 시행해야할 검사는?

**A. 상부위장관내시경**

B. 복부 CT

C. 흉부 엑스선 촬영

D. 복부 초음파

E. 혈관 조영술

8. (본2 Y) 60세 할머니가 관절통으로 왔다. 심장병으로 항응고제 먹고 있고, 5년전에 위장 출혈 있어서 고생했다. NSAID 처방하려고 할 때 해야할 조치는?

A. 관절강 내 Steroid

B. 경과관찰

C. 제산제와 함께 복용한다

**D. 고농도 PPI를 함께준다.**

E. nizatidine과 함께 복용한다

9. BT 38.5, BP 80/50인 환자가 Mental이 쳐진 상태로 응급실에 내원하였다. 오전에 검은색 변을 봤다고 하였다. 즉시 처치해야 할 것은?

**A. 수액 정주**

B. 농축적혈구 수혈

C. (수액이 당연해서 나머지 보기 기억X)

10. S2 segment에 4cm 짜리 mass가 있어서 CT 찍어보았더니 Arterial phase에서 조영되고 그 이후에 washout 되는 양상을 보였다. 이 환자의 수치가 다음과 같을 때 Albumin 4.0 PT(INR) 1.2 Bilirubin 0.8. (표로 3개만 줌) 혼수 없었음. 복수 없었음. 이 환자의 예후에 가장 좋은 것은?

**A. 간 절제술(S2 segmentectomy)**

B. 간 이식

C. 경과관찰

D. TACE

11. HCV로 Follow up 중인 환자가 있다. 의식은 멀쩡하였으나, 복수가 차서 불편감을 호소하며 왔다. 수치 많이 줬음. 정상치는 X. CTP score C정도. 이 환자에게 가장 좋은 처치는 무엇인가?

A. 간 절제술

**B. <u>간 이식</u>**

C. 경과관찰

D. TACE

** 손주현 교수님 부분 2문제 나왔는데, 두 문제가 복기가 섞여있을 수 있으나, 대부분의 학생들이 간이식 하나, 부분절제술 하나 하고 나왔습니다. 시험 직전 BCLC staging 부분 다시 remind하고 가세요 **

**<< 호흡기알레르기내과 >>**

**총 10문제 중 10문제 복원**

1. (연말 야마 보기순서 변형) 34세 남성이 3년 전 결핵을 진단 받고 3개월 간 약제를 복용하다가 증상이 호전되어 자의로 복용을 중단하였다. 2개월 전 기침이 있어 다시 병원에서 결핵을 진단 받고 HREZ 치료를 받고 있는 중이다. 경과를 보기 위해 시행한 검사 상 AFB (+), 말고 검사 하나 더?? 다음 중 옳은 보기를 고른 것은?

(가) Xpert MTB/RIF 검사를 한다.

(나) 1차 치료 실패했다

(다) 약물을 잘 복용하고 있는지 확인한다

(라) Paradoxical response일 수 있으므로 현재 치료를 유지한다

**A. <u>가, 나, 다, 라</u>**

B. 가, 다

C. 나, 라

D.

2. (야마) 60대 남성이 호흡 곤란을 주소로 내원하였다. 다음은 CT, PET-CT 검사 결과이다. (Carina 주변에서 hypermetabolic 한 LN 3군데 보임). 그리고 시행한 검사에서 사용한 기구와 채취한 검체의 육안적 소견 사진을 보았을 때, 이 검사의 이름은?





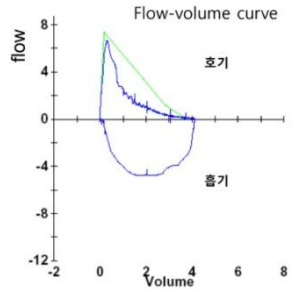

A. Autofluorescence bronchoscopy (AFB)

B. Electromagnetic navigational bronchoscopy (ENB)

**C. <u>Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA)</u>**

D. Transbronchial lung biopsy (TBLB)

3. (야마 변형) 61세 남성, 3개월 전부터 시작된 호흡 곤란을 주소로 내원. PFT 검사 결과상 진단은? (PFT 사진 하나만 줌)




**A. COPD**

B. IPF

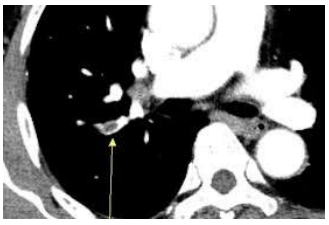
C. Pneumonia

D. Pneumothorax

E.

4. 여자 환자. 폐결핵 앓았던 사람. 하루 전 발생한 호흡곤란으로 내원. 평지 빨리 걸으면 숨차다고 함. 최근에 가래나 기침이 더 증가하지는 않았음. 환자가 숨 찬 원인은? (X-ray에서는 Rt. lung이 쪼그라들어 있었고, CT에서는 심장이 atelectasis 있는 쪽으로 deviation 되어있음.)



(원래 사진에서는 위치가 Lt.(X-ray에서 비교적 정상 같아 보이는 쪽)에 있었음, 화살표도 있었음)

**A. 폐색전증**

B. 기관지 확장증

C. 폐결핵

D. 폐기종

E.

5. 폐결핵 앓은 적 있는 환자. 기침(?)으로 내원. 환절기마다 기침 등으로 고생했고, 전반적으로 호흡음 감소. 흡기 말에 천명음 들림. 진단은?

X-ray 2장(두 달 전, 현재) 둘 다 이상 없었음

PFT 2장(두 달 전 - FEV1, FVC 다 80%대,

현재 - FEV1 50%대, FVC 40%대, FEV1/FVC ratio 70)

A. 폐결핵

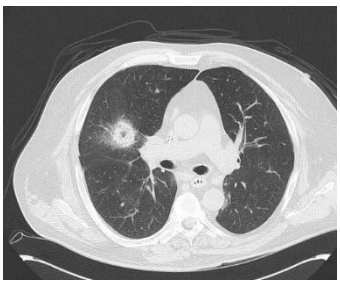
B. COPD

**C. 천식**

D. 만성 기관지염

E.

6. 폐결핵 앓았던 사람. 기관지 세척액에서 Galactomannan (+), AFB (-) 해야 할 치료는?

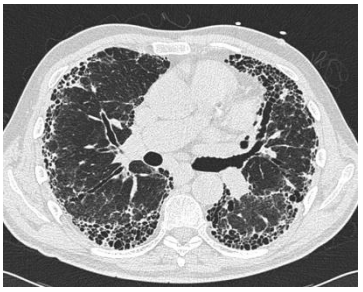


**A. 항진균제**

B. 항생제

C.

7. 호흡곤란, 흡기 말에 수포음이 있는 환자. 치료를 결정하는데 폐기능검사 지표 중에 어떤



것이 가장 치료효과 판정에 좋은가?

**A. FVC**

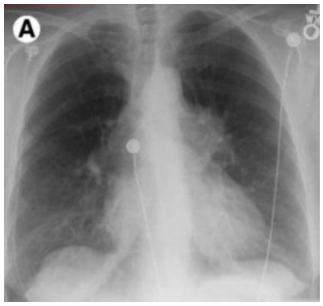
B. FEV1

C. FEV1/FVC

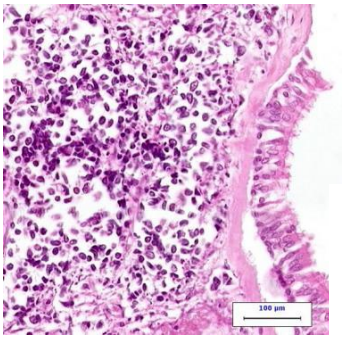
D. TLC

E. DLCO

8. (연말야마변형) Lung mass가 있어 Evaluation 했다. 뼈 스캔 등등 이상 없다. 치료는?







병리 소견은 SCLC였던 것 같아서 SCLC 찾아서 첨부합니다.

A. 항암 단독

**B. 항암+방사선**

C. 수술

D. 수술+방사선

E. 경과관찰

9. 두 달 전부터 평지를 걸어도 힘들다. 40년 간 한 갑씩 흡연. 15년 전부터 금연. 3개월 전부터는 평지를 빠르게 걸어도 숨 차다. 써야 할 약제는?

PFT 결과: FEV1/FVC ratio 70 이상

A. 흡입 스테로이드

**B. LAMA**

C. SABA

D.

10. 3-5일 전부터 열 나는 환자. 체온 38도. 해야 할 치료는?



**A. 항생제**

B. 해열제

C. 점액용해제

**<< 신장내과 >>**

**총 10문제 중 10문제 복원**

1. 63세 여자, 주소가 혈뇨. 고혈압 있었는데, 치료 받지 않음. 알고 보니 두근거림이 있었고, 내원 당시에도 두근거림 있음. 심전도는 다음과 같다. 다음으로 가장 먼저 해야 할 검사는?

[RUA에서 혈뇨, 단백뇨, Dysmorphic RBC 10%.]

A. 신혈관 도플러 초음파

B. 심장초음파

C. 관상동맥조영술

D. Enhance abdomen CT

E. Non-enhanced abdomen CT

2. IgA nephropathy 있는 환자 안 좋은 예후는? (보기에 있는 조건들이 모두 환자 조건으로 서술되어 있었음. 답 논란)

   A. 25세 여자

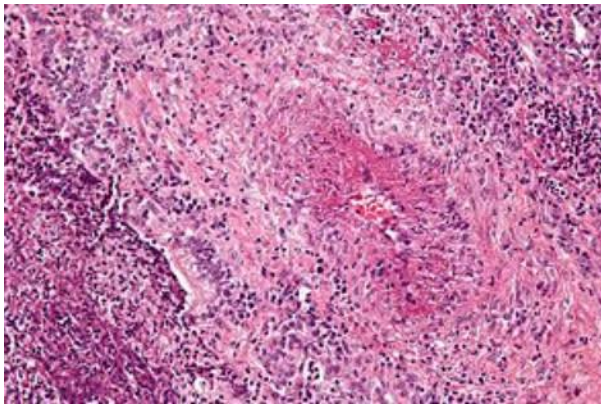
   B. 24시간 단백뇨 4g

   C. 혈압

   D. 육안적 혈뇨

   E. 높은 IgA (400 넘었었음)

3. 단백뇨, 혈뇨, 비강내 용종이 보이는 CT 소견. 사구체 병리소견(구글링)



   **A. GPA (Wegener's granulomatosis)**

   B. Microscopic polyangiitis

   C. EGPA (Churg-Strauss)

   D. Polyarteritis nodosa

4. 발열(39.3도 정도)을 호소하며 소변이 잘 안나오는 여성 환자. 좌측 척추각압통이 있었다. 가장 먼저 처치해야 하는 검사는?

   **A. 일반뇨검사**

   B. 소변배양검사

   C. 복부 CT

   D. 복부 초음파

5. 25세 남자. 혈뇨 및 단백뇨 주소로 내원. 고등학교때도 소변검사시 이상이 있다는 말을 들었다고 한다. 가장 먼저 해야할 검사는?

   **A. 요검사 재검**

   B. 일반뇨검사

   C. 소변배양검사

   D. 신장조직검사

   E. 뇨 화학검사

6. 60/M CKD 환자. 고혈압 등으로 인해 ESRD되어 혈액투석받던 환자가 투석 이후 앉아서 쉬는 도중 갑자기 plasma glc 690대로 뜨고 HbA1c도 10.0이상까지 상승하였다. 원인이 되는 약제는? (답 모름)

   A. Methyl predinisone

   B. Tacrolimus

   C. Cyclosporine A

   D. 나머지 처음 들어보는 약제

7. 40/M 호흡곤란. BUN/Cr 105/12.3 초음파에서 양쪽 신장 위축 소견 흔한 원인은?

   A. 당뇨

   **B. 고혈압**

   C. 만성 신부전

8. (연말Y) 고혈압이 있는 여환. 170/110 정도. 혈압이 조절이 안된다고 내원 소변 검사상 혈뇨 소견 있음 신장 초음파상 신장 크기는 11cm 해야 할 것?

   **A. 신장혈관도플러**

   B. 신장조직검사

   C. 일반뇨검사

9. 50세 남자. 갑자기 발열, 피부병변 나타나 내원함. 통풍약 먹었던 병력이 있다. 여러개 검사 소견 있고 ANA(-) 였고 C3 C4 수치는 정상이었다. 진단?

   A. IgA nephropathy

   B. PSGN

   C. MPGN

   D. ATN

   **E. <u>Renal cortical necrosis</u>**

10. 조조강직. 관절통. 얼굴에 명확한 홍반 있는 환자. 신기능이 나빠서 신장이식을 받음. 면역억제제 먹는중. 1달전 Cr 1.2, 이후 재검사했더니 Cr 3.0 나옴. 이때 고려할 것으로 옳은 것?

    A. 신기능이 매우 나빠졌으므로 입원하여 steroid pulse(지문에서는 한글말로 나옴) 해야 한다.

    B. 소변 검사 + ? 는 초기 진단 감별에 있어서 유용하므로 쓰면 좋다.

    C. IgA콩팥병증때문에 이식한 거라서 예후가 안좋다?

    D. 크레아니틴의 상승은 급성 신부전으로 인한 것이므로 혈중 스테로이드 농도 잴 필요 없다.

    E. 혈액검사 할 필요 없다.

**<< 감염내과 >>**

**총 5문제 중 4.5문제 복원**

Cf. 김지은 교수님에서 김봉영 교수님으로 교체되어 all 탈야마. 대부분의 문제에서 항생제 감수성 표가 나왔습니다. 해석법 숙지하시길 바랍니다. + 병원감염 예방 김지은 교수님 내신야마 부분 숙지하면 도움됨.

1. klebsiella pneumoniae에 대한 항생제 감수성은 아래와 같다. 이 균에 감염된 환자와 접촉할 때 의료진의 보호 장구를 고르시오.

   (Resistance 표, Imipenem R)

   **A. <u>Surgical mask</u>**

   B. Disposable gown

   C. N95 mask.

   D. ?

   E. 아무조치도 안한다

2. Central catheter를 넣을 때 CLABSI 감염을 방지하기 위해 예방적으로 해야하는 것은? (김지은 교수님 병원감염예방 매뉴얼 참고.)

   A. 예방적 항생제 사용.

   B. 카테터 자주 교체.

   **C. <u>필요가 없어지면 최대한 빨리 제거.</u>**

   D. Femoral a를 통해 삽입한다

   E. ?

3. 감염성 체액에 노출되었을 때 대처법은?

   A. 대변 치우고 알코올 손 소독.

   B. 혈액 엎은 바닥 대걸레로 청소.

   C. 환자 쓴 주사 바늘 찔렸을 때 피 짜내기.

   **D. <u>기침하는 환자 볼 때 마스크.</u>**

   E. ?

4. 3일 전부터 오른쪽 다리가 붓고 열감 있는 S.aureus 여자 환자. 무슨 항생제 써야하나?

   (항생제 내성 엄청 많은 균; Penicillin R, Oxacillin R, Daptomycin S, Linezolid S)

A. Vancomycin

B. Piperacilin

**C. <u>Linezolid</u>**

D. Ampicillin

E. Azithromycin

5. 또 다른 S.aureus 문제. 다른 항생제 감수성 표가 있었음. 써야 할 항생제는?

**<< 내분비내과 >>**

**총 5문제 중 5문제 복원**

Cf. insulin 맞는 DM 환자에서 혈당 조절 이 안될 때 조절해야 하는 insulin(KMLE 참고) + 골다공증의 판별법 및 정의 (KMLE 보단 진단 guideline 참고하는 게 나을 듯) + 당뇨의 정의

1. 65세 여자 환자에서 시행한 골다공증 검사이다. (t score, z score) L1, L2, L3, L4 수치 제공

   Femur Rt, Lt = -2.4

   L1 ~ L4 평균 – 2.4 이내

   L1 ~ L4 중 -2.4 보다 작은(절대값이 큰) 수치 2개 있었음.

   A. Osteopenia.

   **B. <u>Osteoporosis</u>**

   C. 정상

   Cf. 정의 찾아보시면 알겠지만 L1~L4 평균이 -2.4 보다 작아도 2개 이상 -2.5 보다 작은게 있다면 Osteoporosis 입니다. (내분비 F 컨펌)

2. 20살 남학생이 공복 혈당 106 으로 내원하였다. 75g OGTT 소견 30분 60분 120분 수치.

   2시간 180. Hba1c 6.0%

   상기환자 진단은?

   A. 정상

   B. 공복혈당장애

   C. 내당능장애.

   D. 공복혈당장애 + 내당능장애

   E. 당뇨

3. (18연말 변형) 45세 남자 외래를 통해 당뇨 조절을 문의하여 방문하였다. 당뇨 모니터링 결과 식후 2시간 후 혈당이 높은 것으로 보인다. 다음 중 사용해야하는 인슐린의 종류는? (성분명이 아닌 상품 명들이 사진으로 주어졌고, 사진 확대시 glulisine만 성분명이 보였습니다. )

   A. NPH

   B. glarzine

   **C. <u>glulisine ?</u>**

   D. Novo mix

   E. Novo rapid

4. (18연말 Y) 35세 여자 환자 갑상선기능저하증으로 레보사이록신 복용중인 환자이다. 아래는 환자 TSH, fT4 수치이다.

   TSH : 정상 범위 fT4 ; 정상범위 ( lower margin ) 정상범위 줌.

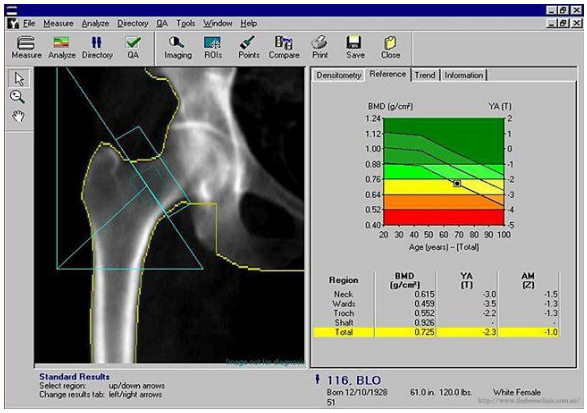
   A. Levo 12.5증량

   **B. <u>Levo 용량유지.</u>**

   C. Levo 25증량.

   D. Levo 감량.

5. 65세 여자환자 골다공증 검사 시행하였다. 상황 상 lumbar 의 dxa 는 시행하지 못하고 femur 만 시행하였다. ( dxa 그림 주고 무엇인지 맞추기 )




이것과 같은 형식의 차트였습니다.

Femur neck 수치 1개

Femur body 수치 1개 이런 식으로 주어졌음.

진단은?

A. Osteopenia

B. Osteoporosis

C. Normal

**<< 혈액종양내과 >>**

**총 5문제 중 4문제 복원**

Cf. 원영웅 교수님 마약성진통제 문제 KY입니다. 암성통증 조절 권고안 참고하세요.

1. (주관식) Corrected Reticulocyte count 구하기. 여러가지 수치 섞여서 나오고 reticuloccyte 1.2%, hct 20.3 Hb 6.9. (반올림하여 소수점 첫째자리까지 적으시오)

A. Hb 로 구할때랑 Hct 로 구할때랑 답이 달랐음.
B. Hct 로 구하면 0.54%, Hb 로 구하면 0.51% 정도로 나왔음.

2. 고혈압과 당뇨를 앓고 있던 환자가 어지럼증을 호소하며 외래로 내원하였다. 혈액검사를 시행한 결과는 다음과 같다. 치료는?

Serum Fe 떨어져 있었음.

Mcv 92fL

ferritin tibc transferrin VitB12 : Normal

reti 1점대 corrected reti로 계산하면 0.8

**A. <u>PO 철분제</u>**

B. EPO 처방

C. 농축적혈구 수혈

D. Vit B 12 주기

E. Folate 투여

3. 이 환자의 IPI index 에 따른 Score는?

여러가지 수치 줬음.

Age 37M

ECOG stage1 LDH 상승

PET-CT 찍어보니 양측 Supraclavicular node에 high signal을 보였다.

Extranodal 없었음. (BM – Liver – Abdomen -)

**A. <u>Low risk</u>**

B. Low – intermediate risk

C. High – intermediate risk

D. High risk

4. 췌장암의 전이가 심하여 수술 불가상태여서 Chemo로 보존적인 치료만 하는 환자. 상복부 통증이 매우 심하여 응급실로 내원하였다. 마약성 진통제를 사용했던 경험은 없다. 이 환자에게 어떤 진통제를 줘야

하는가?

**A. IV Pethidine**

B. PO morphine (은 Oddi spasm 일으켜 복통 시 금기)

C. Fentanyl patch

D. Acetaminophen

E. Ibuprofen

**<< 류마티스내과 >>**

**총 4문제 중 4문제 복원**

1. Biologic dmard와 무관한 것?

   A. TNF-alpha

   B. cd20

   C. IL-1

   D. Il-6

   **E. Cd40L-Cd40**

2. SLE 환자. 얼굴에 발진, 두통 보이고 SIe 관련 항체들 수치 주어짐. 다음으로 할 검사? :

Cr 2.0 19-20 RBC/HFU 단백뇨 2.0g/24hr

   **A. 신장 생검**

   B. Brain MRI

   C. Abdomen US

   D. 일반뇨검사

   E. Abdomen CT

3. 44세 여자가 손목 팔꿈치 발목의 관절 통증으로 내원 부종과 압통있었고 조조강직 있었음. 진단에서 가장 특이도 높은 검사는?

   A. RF

   B. HLA-B27

   C. CRP

   D. ESR

   **E. Anti-CCP Ab**

4. 22세 남성 1개월 전부터 발목 통증 아침에 증상 심하고 오후에는 나아짐. 4개월전 포도막염 진단 발목부착부 건에도 통증 있음 가장 가능한 진단은? (답 논란)

   A. 건선

   B. 반응성 관절염

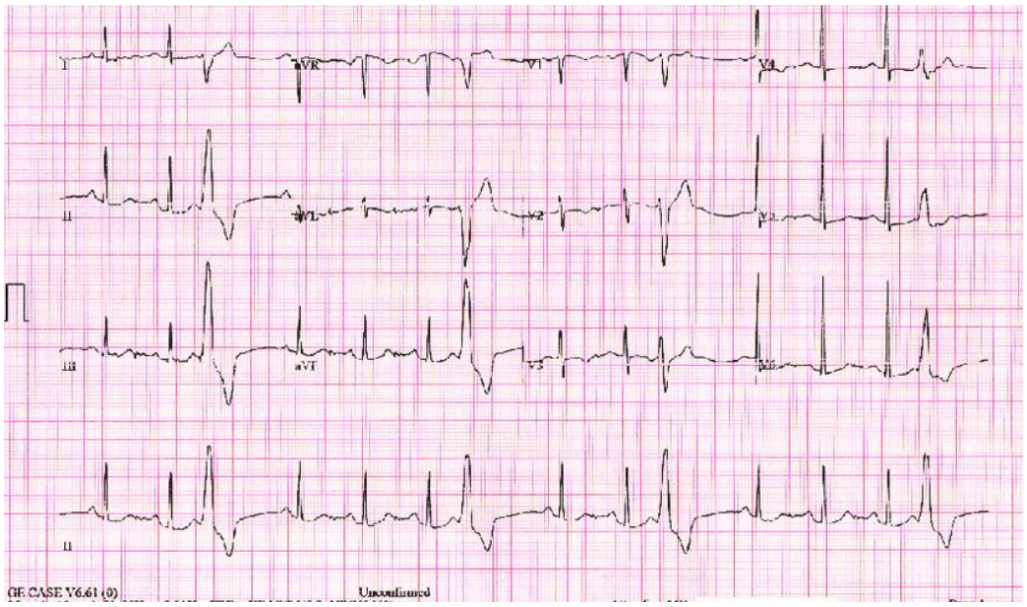
   C. 척추관절염

   D. 강직성 척추염

**<< 심장내과 >>**

**10문제 중 10문제 복원**

1. 27세 여자 두근거림 주소로 내원. 3년간 두근거림 증상 있었고 갈수록 빈도가 많아지고 심해짐. 심전도상 VPC. 치료는?



A. Beta Blocker

B. Digoxin

C. Amiodarone

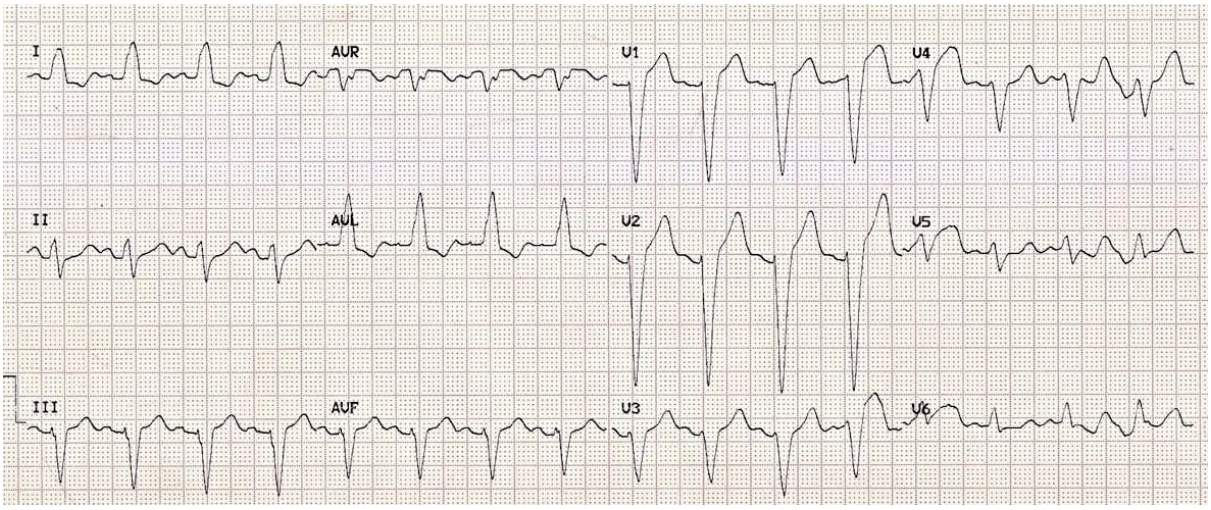
D. ICD

E. Pacemaker

2. 67세 남자 심한 호흡곤란. 고혈압약 복용중인 환자. CHEST X-ray 에서 cardiomegaly. 심구혈율 28% 심전도상 LBBB 소견.

치료는?





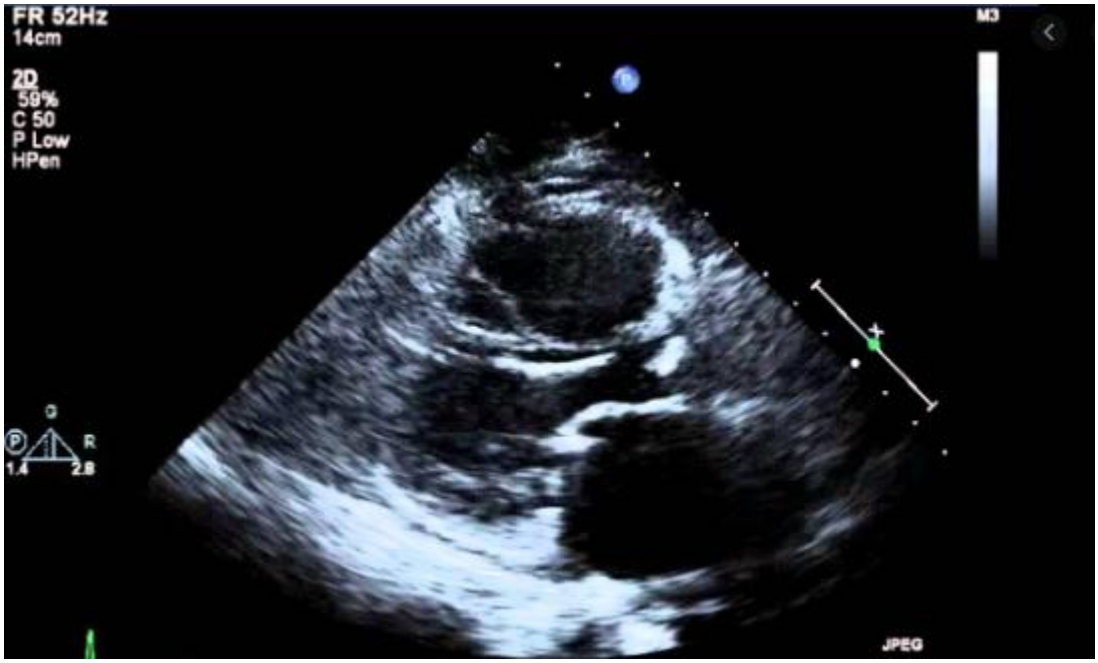

A. 제세동 기능 있는 심장 재동기화 기계 삽입 CRT-D

B. 제세동 기능 없는 심장 재동기화 기계 삽입 CRT-P

C. Permanent pacemaker

D. Beta blocker

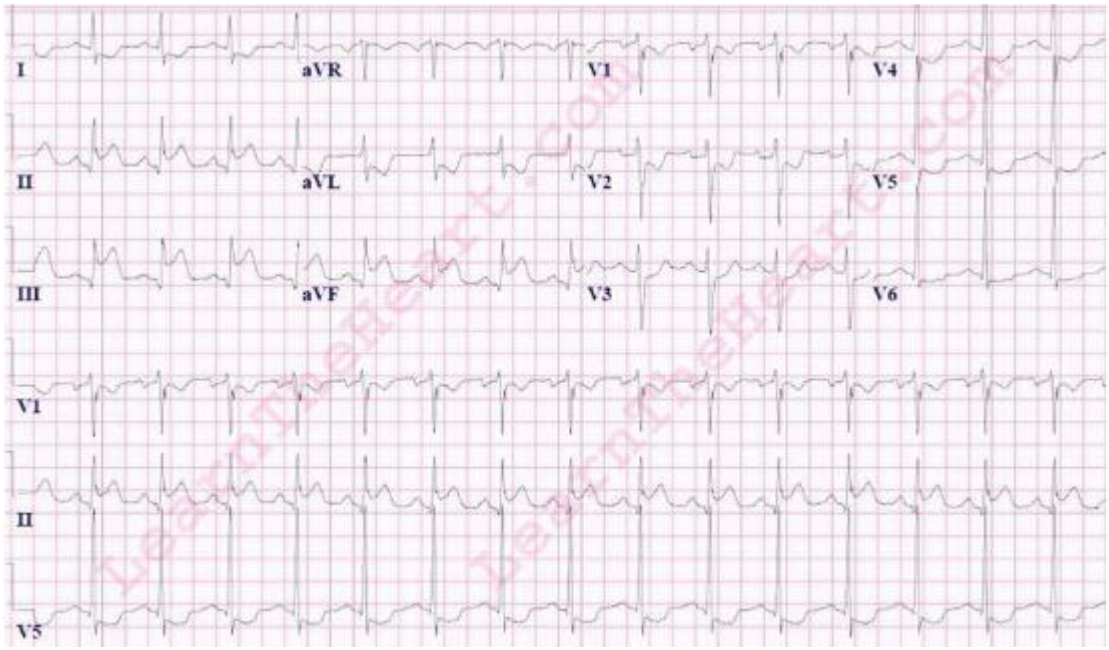
3. 호흡곤란 환자. BP 100/80 심초음파상 mitral stenosis. ECG상 A fib. 치료는?




A. 와파린이 아닌 경구항응고제

B. 승모판치환술 + MAZE

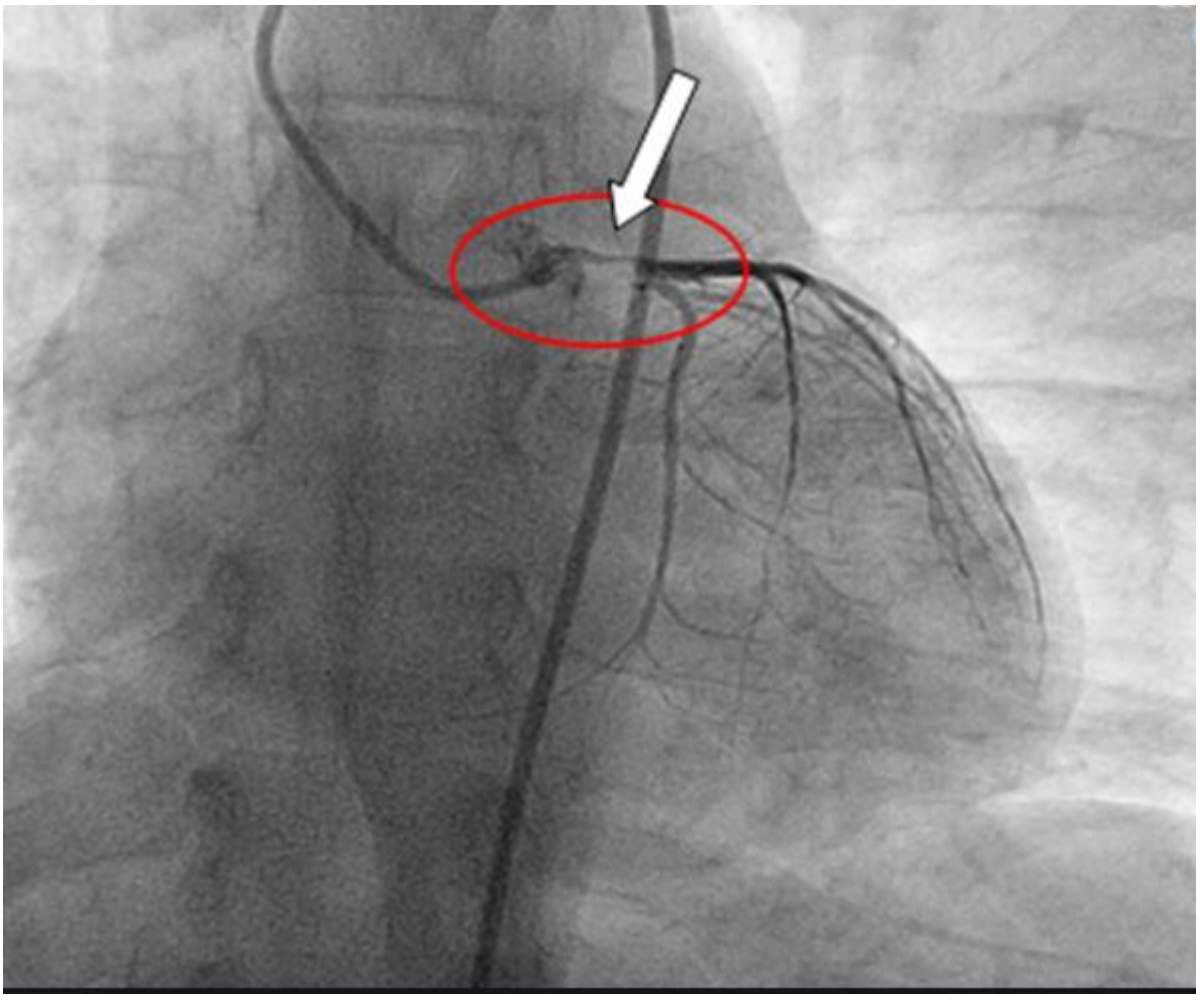
4. 호흡곤란 호소하는 환자. 혈압 80/60 ECG II, III, avF lead에 st elevation. 치료는?




A. 피부경유혈관조영술

B. 수액치료 보기에 없었음

5. CAG 사진 주고 무슨 혈관에 occlusion 생겼는가?



A. Left main coronary artery

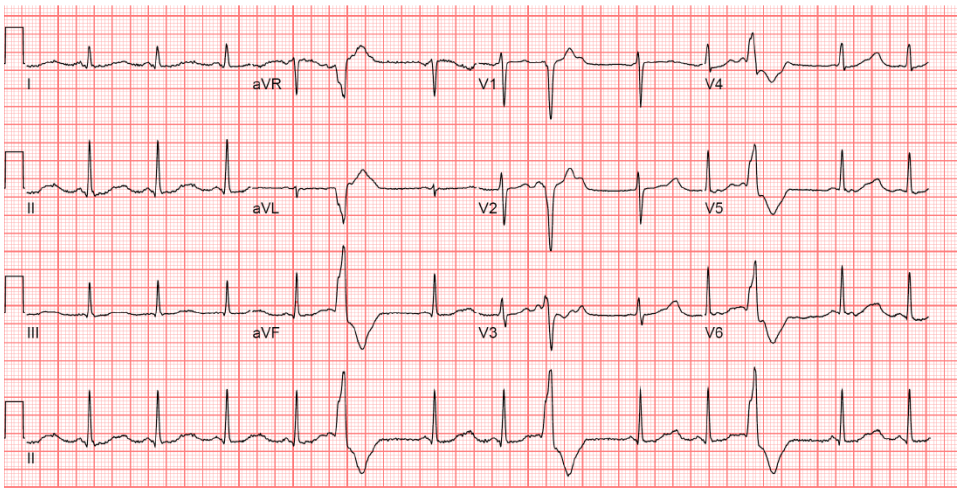
B. LAD

C. LCX

D. RCA

(시험에서 봤던거랑 가장 비슷한 사진.. LAD인지 Left main coronary artery인지 논란이 있었습니다. CAG에서 혈관 고르는건 한 문제씩 출제되는 것 같으니 공부하시는게 좋을 것 같아요.)

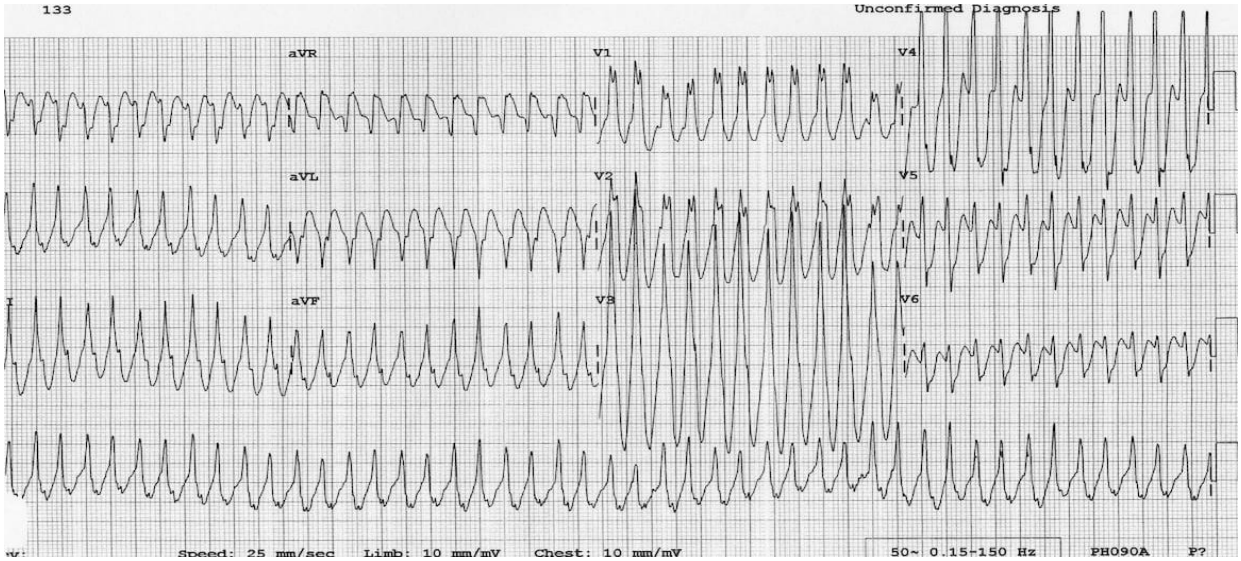
6. 심전도상 long QT syndrome. 치료는?

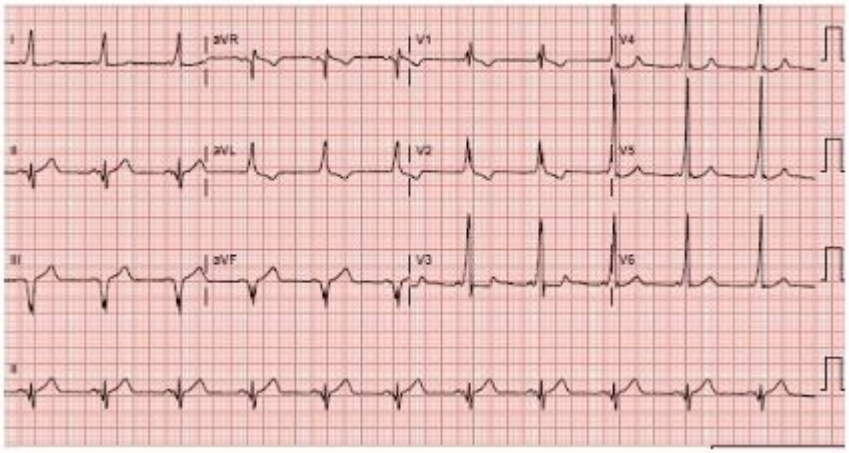



A. 영구 Pacemaker 삽입

B. ICD

7. 환자 두근거림 호소. 약물 투여 전후 심전도 사진. 첫번째 심전도는 심실빈맥과 같은 양상의 EKG. 두번째는 WPW 진단은?



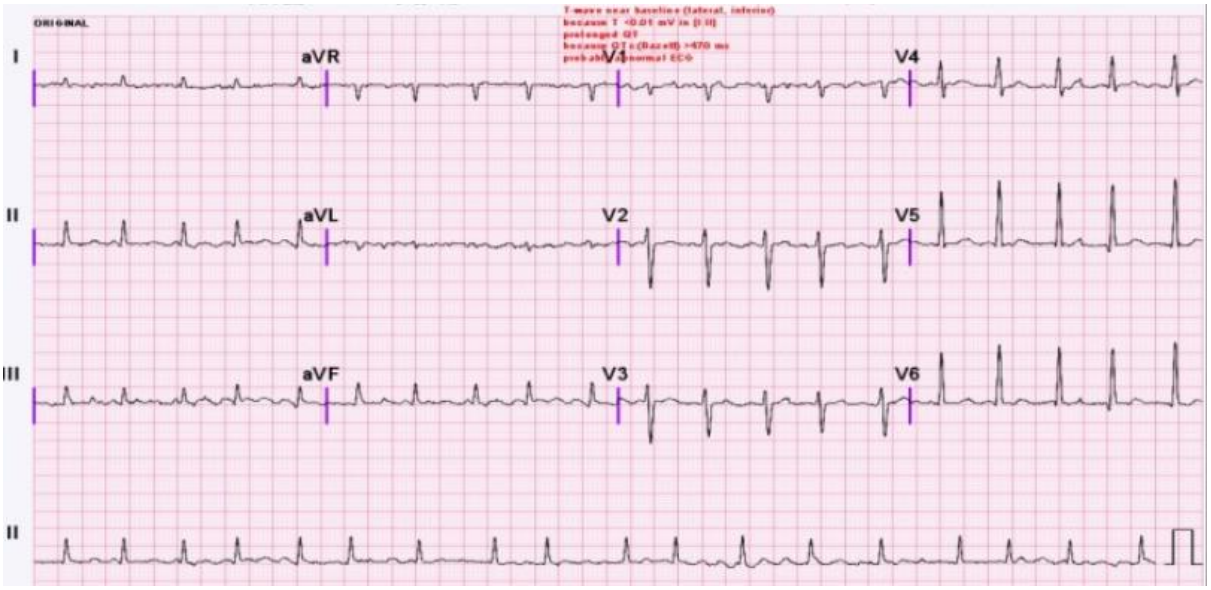



A. 조기흥분증후군

B. VPC

C. 심실빈맥

8. 두근거림 호소. HR 140 EKG 주어지고 진단은?




A. 심방세동

B. 심방조동

C. 심실세동

9. 2년 전 쯤 부터 쥐어 짜는 듯한 가슴통증 호소했으나 최근 들어서 그 정도가 심해졌으며 2일 전 부터는 가만히 쉬고있어도 가슴통증이 생겼음. ECG 정상. TROPONIN 정상. 진단은?

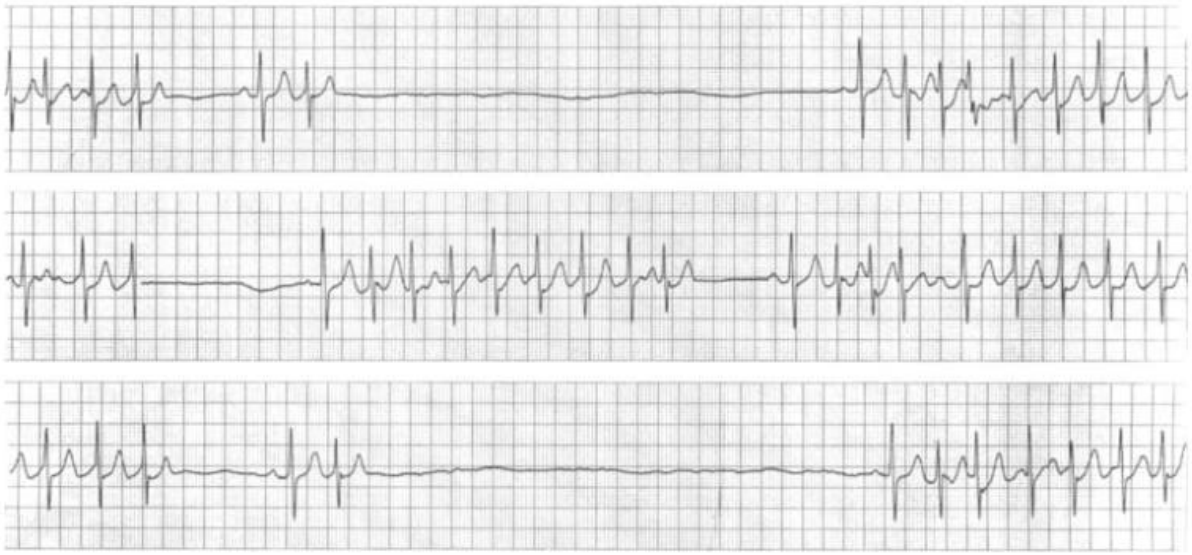
   A. 안정 협심증

   B. 불안정 협심증

   C. STEMI

   D. NSTEMI

10. ECG (Tachycardia-bradycardia syndrome) 보여주고 치료는?



   A. Permanent pacemaker

   B. ICD

   C. Beta blocker